纪要

主题: 百利天恒ISMR数据解读 时间: 2026-10-27 13:25:47 参与人: 前沿信息收录 V:FCCNN88



本次百利天恒ISMR数据解读会议围绕核心管线BL-B01D1（艾沙伯瑞/Ezbrain）在EGFR突变非小细胞肺癌及HR阳性乳腺癌等适应症的临床数据展开，详细披露了二线及一线治疗的优异疗效与安全性profile。管理层重点解读了全球三期临床进展、商业化团队搭建及医保谈判预期，确认该药物在多个瘤种中展现出 Best-in-Class 潜力，并规划了未来与BMS双抗联用的战略方向。

会议背景与嘉宾介绍

- 会议概况
  - 本次会议为中信证券白名单会议，旨在解读百利天恒在ISMR年会上发布的BL-B01D1多

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

项重磅适应症数据。
- 参会嘉宾包括百利天恒创始人、董事长兼首席科学家朱总，以及董事、常务副总经理兼财务总监张总。
- 主持方为中信证券医药研究员安飞，联合中金公司、中信建投、广发证券等22家券商分析师共同主持。

EGFR突变非小细胞肺癌临床数据解读

· TKI耐药二线治疗数据（对比化疗）

- 研究设计：针对经第三代TKI治疗耐药的二线患者，入组标准严格，100%患者经过三代TKI治疗，ECOG评分1分占比超70%。
- 疗效数据：主要终点中位PFS为 11.1个月 vs 对照组 5.7个月，HR=0.4，P value=0.0001；ORR为 67.6% vs 对照组 41.7%，确认ORR为 60.2%。
- 生存获益趋势：尽管OS数据尚不成熟，但12个月及18个月OS率呈现明显获益趋势；即使对照组后续有30%患者交叉使用ADC治疗，实验组仍保持显著优势。
- 肿瘤缩小比例：91.2% 的患者治疗后肿瘤缩小，对临床医生和患者具有重要信心支持。
- 安全性：因不良反应停药率为 1.9%，与对照组相当；间质性肺病（ILD）发生率为 0.9%（1例1级，1例3级），整体毒性可控，主要为血液学毒性。

· 一线联合奥希替尼二期更新数据

- 研究队列：共入组123例患者，涵盖2.2mg、2.5mg、2.75mg三个剂量组；其中2.5mg剂量组40例患者，ECOG 1分占比80%，脑转移比例较高。
- 2.5mg剂量组疗效：ORR达到 100%，确认ORR为 97.5%；中位DoR和PFS尚未达到；24个月PFS率为 87%，27个月PFS率为 83.8%；27个月OS率为 91.5%。
- 整体疗效对比：全人群（123例）礼盒法计算的中位PFS为 40.7个月，2.5mg组估算中位PFS达 66.5个月，显著优于奥希替尼+培美曲塞（中位PFS约25-27个月）。
- 耐受性与持续性：2.5mg组中位治疗时长达 26.9个月，因不良反应停药率在总人群中为14.6%，2.5mg组为12.5%，显示出良好的长期用药可持续性。
- ILD安全性：全人群仅2例发生ILD（1例2级，1例3级），发生率极低。

HR阳性乳腺癌临床数据解读

· 经CDK4/6抑制剂治疗后数据
- 患者基线：入组患者为重度治疗人群，80%以上接受过辅助治疗，71%伴有肝转移，64%接受过放疗，包含部分6个月内进展的高危患者。
- 疗效数据：中位PFS为 8.2个月 vs 对照组 4.0个月，HR=0.41，P value=0.00001；数据发表于《柳叶刀》，是中国乳腺癌研究首次在该刊发表。
- 安全性：因不良反应停药率为 1.6%，与化疗组（1.0%）接近；ILD发生率为 1.1%（2例），整体安全性可控。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

其他适应症与研发管线进展

- 头颈鳞癌及其他瘤种策略
  - 头颈鳞癌：规划采用“双抗+ADC”策略（帕米加BL-B01D1），暂不联合PD-1；优先级排在肺癌和乳腺癌之后，预计2025年后启动相关大型三期临床。
  - 膀胱癌：海外注册进度显示，尿路上皮癌二线治疗有望在2029年实现首个大三期临床商业化。
  - HER2阴性乳腺癌：针对未接受化疗的HR阳性/HER2阴性乳腺癌三期临床正在入组，预计5-6个月内完成入组。
- 生物标志物分析
  - EGFR与HER3表达：临床样本分析显示，EGFR与HER3同时不表达的情况极少；未发现EGFR或HER3表达水平与疗效或安全性存在明确相关性，证实双靶点设计的生物学基础正确性。
  - 亚组分析：脑转移患者与非脑转移患者在PFS和ORR上无显著差异；Exon 20插入突变亚组数据略好但无统计学意义，需更长随访验证。

商业化准备与医保谈判

- 商业化团队搭建
  - 团队规模：目前商业化团队近700人，预计年底达到 800人，覆盖所有省会及重要地级市，建立完整的销售、市场、医学、准入及商务合规体系。
  - 合规策略：坚持真实合规的商业化路径，通过半年测试期评估渗透率和成长速度，将于年底提供更准确的商业化指引。
  - 获批预期：已有5个适应症报产，预计明年上半年至下半年陆续获批上市。
- 医保谈判情况
  - 谈判进展：与国家医保局沟通顺利，获得了真正的创新药价位预沟通资格（肿瘤领域少数获得此地位的药物之一）；最终结果将于11月14日公布。

全球临床进展与合作伙伴动态

- 全球三期临床进度
  - EGFR突变一线全球三期：由BMS主导，已启动；中国地区入组已完成，全球入组计划约2.5年完成，预计2029年初完成入组，2030年中可能读出数据。
  - 入排标准：全球研究对照组纳入奥希替尼+培美曲塞，标准较国内更前沿；中国患者占比预计15%-20%以满足NMPA获批要求。
  - 监管终点：二线治疗以PFS为主要终点，OS为次要终点（不可反转），符合CDE及

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

FDA当前对长PFS药物的审评惯例。

- 与BMS合作及双抗联用
  - 合作策略：BMS高度重视该适应症，认为其在突变型及野生型肺癌中均有上百亿美金市场潜力；双方正推进BL-B01D1与BMS双抗（如帕米加）的联用早期临床。
  - 联用进展：肺癌和乳腺癌联用数据已支持向FDA沟通开展全球三期临床，预计2025年上半年启动相关大型研究。
  - 头对头研究：计划与DS-8201进行头对头研究，目前早期二期随机对照研究正在入组，预计2025年6月获得数据以决策是否启动全球三期。
- 未来数据读出计划
  - 近期里程碑：2024-2027年为数据密集读出期，包括多个Pivotal研究撞线；2025年将陆续公布早期双抗联用数据以促进全球三期入组。
  - TROP2 ADC等其他管线：基于同一小分子毒素平台的其他ADC管线（如TROP2 ADC）也展现出一致性的Best-in-Class潜力，信心充足。

AI洞察

- 数据驱动的商业化自信：BL-B01D1在EGFR突变肺癌二线治疗中取得11.1个月的中位PFS，显著优于现有标准治疗，且安全性可控（ILD发生率<1%），这种“断崖式”的数据优势使得公司在商业化推广中具备极强的自然吸引力，降低了传统营销依赖。
- 全球合作深化与市场潜力：与BMS的深度合作不仅加速了全球三期临床进程，更通过“双抗+ADC”的策略拓展了野生型肺癌等更大市场空间，管理层预测该单一适应症潜在市场规模可达上百亿美金，体现了从“跟随”到“引领”的战略转变。
- 合规先行与长期主义：公司在商业化团队搭建中强调“真实合规”，即便面临短期市场挑战，也坚持不为未来埋下隐患，这种策略有助于在国际化和国内医疗反腐背景下实现可持续增长，并为后续出海奠定坚实基础。

章节

- 00:02:37 EGFR突变非小细胞肺癌二线治疗数据解读
  - 朱总解读艾沙布林联合奥希替尼对比化疗的二期临床数据，中位PFS达11.1个月，显著优于对照组的5.7个月，HR为0.4，ORR为67.6%。安全性方面停药率低，主要毒性为血液学毒性且可控，ILD发生率极低。
- 00:10:41 非小细胞肺癌一线治疗更新数据
  - 展示艾沙布林联合奥希替尼一线治疗的Update数据，2.5mg剂量组ORR达100%，中位PFS尚未达到，27个月PFS率为83.8%。整体队列中位PFS达40.7个月，显示出极长的持

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

续用药时间和良好的耐受性。

- 00:18:19 HR阳性乳腺癌后线治疗数据解读
    - 解读HR阳性/HER2阴性乳腺癌后线治疗数据，患者基线较重，中位PFS为8.2个月 vs 对照组的4.0个月，HR为0.41。安全性良好，停药率低，ILD发生率仅1.1%。该研究数据发表在《柳叶刀》。
- 00:23:50 全球三期临床进度与商业化准备
    - 回答分析师提问，透露全球三期临床入组顺利，预计2029-2030年读出数据。国内商业化团队年底将达800人，坚持合规销售，医保谈判顺利，预计明年多个适应症获批上市。
- 00:46:41 其他适应症进展与亚组分析问答
    - 解答关于脑转移亚组、EGFR/HER3表达与疗效相关性、双抗联用早期临床进展等问题。朱总表示未看到生物标志物与疗效的相关性，双抗联用数据支持开展全球三期，预计明年启动。
- 01:09:48 总结展望与会议结束
    - 朱总总结公司管线丰富，艾沙布林数据一致性强，获颁Best ADC奖项实至名归。对未来小分子平台及其他ADC管线充满信心，感谢投资者支持。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88